

KETERKAITAN LESI ENDO-PERIO (Tinjauan Pustaka)

THE ENDO-PERIO CONTINUUM (Literature Review)

Nuzulul Ismi¹, Agus Susanto²

¹Departemen Periodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Syiah Kuala

²Departemen Periodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjajaran

Corresponding Author: nuzululi@yahoo.com

Abstrak

Kasus lesi endo-perio merupakan kasus yang sering ditemui dalam praktek kedokteran gigi. Hubungan antara penyakit pulpa dan periodontal (lesi endo-perio) pertama kali dikemukakan oleh Simring dan Goldberg pada tahun 1964. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang hubungan lesi endo-perio dan penatalaksanaannya. Lesi endo-perio disebabkan oleh adanya inflamasi pada area pulpa dan jaringan periodontal secara bersamaan pada satu gigi. Keterkaitan pulpa dan jaringan periodonsium melalui jalur anatomi dan non-fisiologis. Jalur secara anatomis melalui foramen apikal, kanal lateral dan tubulus dentin, sedangkan jalur non-fisiologis seperti perforasi iatrogenik, trauma, fraktur gigi vertikal, perawatan periodontal yang tidak adekuat, dan lainnya. Perawatan lesi endo-perio bertujuan menghilangkan inflamasi pada area pulpa dan jaringan periodontal. Pemeriksaan secara komprehensif diperlukan, meliputi pemeriksaan klinis dan radiograf yang dapat membantu dalam menegakkan diagnosis melalui tanda dan gejala klinis serta mengklasifikasikan lesi endo-perio sehingga perawatan yang tepat dapat dilakukan. Pemeriksaan tanda dan gejala klinis dalam menentukan diagnosa lesi endo-perio penting dilakukan untuk menentukan perawatan yang tepat.

Kata Kunci: Diagnosis, Etiologi, Klasifikasi, Lesi Endo-Perio

Abstract

Endo-perio lesion is a commonly occurred case in dentistry. The connection between pulp and periodontal disease was firstly described by Simring and Goldberg in 1964. This article aims to explain the relationship between endo – perio lesion and its treatment. Endo-perio lesions are caused by inflammation of the pulp area and the periodontal tissues that occur simultaneously on a tooth. Pulp and periodontal tissue are related through from anatomy and non-physiological pathways. The anatomical pathways are foramen apical, canal lateral and tubulus dentin, while the non-physiological are iatrogenic perforation, trauma, vertical fracture of the teeth, inadequate periodontal treatments, and others. Comprehensive examination including clinical examinations and radiographs are required in order to make an accurate diagnosis through clinical signs and symptoms and classifying endo-perio lesions so that appropriate treatment can be performed. Examination of clinical signs and symptoms in determining the diagnosis of endo-perio lesions is performed to determine the proper treatment selection.

Keywords: Diagnosis, Etiology, Classification, Endo-Perio Lesion

PENDAHULUAN

Keterkaitan pulpa dan jaringan periodonsium dimulai dari tahap perkembangan embrio gigi, dental folikel menjadi tanda dari adanya jaringan periodonsium yang memiliki hubungan dengan papilla gigi yang menjadi asal dari jaringan pulpa. Keduanya dipisahkan oleh epitel Hertwig. Dengan demikian pulpa dan jaringan periodonsium memiliki hubungan embrio, fungsional dan anatomi.¹⁻⁴ Hubungan antara lesi endodontik dan periodontal pertama kali dikemukakan oleh Simring dan Goldberg pada tahun 1964 yang dikenal istilah lesi endo-perio.^{3,4}

Jaringan periodonsium dan pulpa gigi secara anatomi berhubungan melalui foramen apikal dan lateral, yang memungkinkan masuknya patogen antara kedua anatomi yang berbeda ini.^{2,4} Meski ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan lesi endo-perio, penyebab utama keduanya adalah adanya infeksi bakteri dengan flora mikroba kompleks. Obligat anaerob yang mendominasi area ini adalah *Streptococcus*, *Peptostreptococcus*, *Eubacterium*, *Bacteroides* dan *Fusobacterium*.^{2,5}

Lesi endo-perio ditandai dengan adanya keterlibatan penyakit pulpa dan periodontal pada gigi yang sama. Sangat penting untuk mengenali keterkaitan keduanya yang menunjang keberhasilan perawatan akhir dari lesi ini.^{2,6} Jalur penyebaran infeksi masih kontroversi karena adanya pengaruh seperti anatomi (foramen apikal, aksesori, kanal lateral dan kanal sekunder, tubulus dentin), patologi dan iatrogenik.^{2,5} Identifikasi dan eliminasi etiopatogenesis primer dari kondisi yang ada adalah kunci utama untuk keberhasilan perawatan.^{1,8}

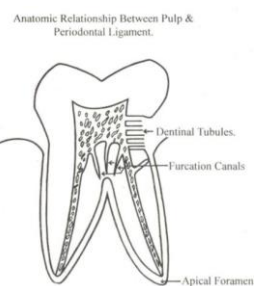
TINJAUAN PUSTAKA

Infeksi persisten jaringan pulpa menyebabkan infeksi sekunder dan kerusakan jaringan periodonsium. Sebaliknya, penyakit periodontal kronis dapat menginisiasi atau menyebabkan eksaserbasi inflamasi di jaringan pulpa. Hubungan antara infeksi pulpa dan periodonsium dimediasi dengan adanya hubungan antara kedua struktur anatomi ini. Jalur komunikasi utama adalah foramen apikal. Pulpitis berlanjut menyebabkan nekrosis pulpa yang seringkali diiringi resorpsi tulang pada apeks, seperti yang terdapat pada kasus periodontitis apikal atau abses apikal. Kasus seperti ini disebut periodontitis *retrograde*

karena pada gambaran klinisnya terdapat kerusakan jaringan periodontal dari apikal ke arah servikal. Kasus ini merupakan kebalikan dari periodontitis *orthograde* yang disebabkan adanya infeksi sulkular yang berkelanjutan.^{7,8}

Masuknya bakteri dan produk-produknya ke dalam pulpa dan jaringan periodonsium dibagi kedalam beberapa jalur yaitu:^{3,5,9,10}

1. Jalur anatomi, meliputi pembuluh darah seperti foramen apikal, kanal aksesori/lateral dan tubulus dentin. Foramen apikal adalah jalur langsung antara periodonsium dan pulpa. Penyakit periodontal telah terbukti memberi efek destruksi pada jaringan pulpa jika plak bakteri melibatkan foramen apikal yang mempengaruhi suplai pembuluh darah. Iritasi dari penyakit pulpa dapat menginvasi melalui foramen apikal yang mengakibatkan patosis area periapikal.^{1,7,10} Kanal aksesori merupakan jalur potensial dalam penyebaran mikroorganisme dan produk toksiknya, serta iritasi lainnya dari pulpa ke ligamen periodontal ataupun sebaliknya yang mengakibatkan proses inflamasi pada jaringan yang terlibat.^{2,9} Tubulus dentin merupakan jalur masuknya mikroorganisme antara pulpa dan jaringan periodontal saat lapisan sementum terbuka. Hal ini disebabkan oleh berbagai defek perkembangan seperti inkomplit sementum dan enamel pada *cemento-enamel junction* (CEJ), penyakit atau prosedur bedah yang melibatkan permukaan akar seperti skeling dan *root planning* yang kurang tepat.^{2,8,9}
2. Jalur nonfisiologi meliputi perforasi saluran akar secara iatrogenik, fraktur akar vertikal, trauma, kehilangan sementum karena iritan eksternal, resorpsi internal dan eksternal, dan lain-lain.^{3,5,7,9}



Gambar 1. Jalur Anatomi Lesi Endo-Perio Melalui Foramen Apikal, Kanal Aksesori, dan Tubulus Dentin⁹

Penyakit pulpa diinisiasi oleh berbagai faktor eksternal seperti mikroorganisme, trauma, panas yang berlebihan, prosedur restorasi, agen restorasi, dan lain-lain. Hal

tersebut menyebabkan perubahan inflamasi pada pulpa, yang dimulai dari pulpitis reversibel atau ireversibel yang berkembang menjadi nekrosis pulpa dan berlanjut mengalami kerusakan pada jaringan periodonsium. Karies adalah penyebab utama penyakit pulpa. Infeksi pulpa merupakan polimikrobial dan seringkali diawali oleh karies yang menyebabkan pulpitis atau inflamasi pulpa terlokalisir.^{2,8,9}

Ketika pulpa menjadi nekrosis akan menyebabkan respon inflamasi pada jaringan periodonsium sehingga mempengaruhi serabut *fiber* jaringan periodontal, resorpsi tulang alveolar dan sementum.⁵ Sebaliknya keadaan inflamasi pada jaringan periodontal dapat mengakibatkan nekrosis pulpa bila bakteri plak dapat mencapai foramen apikal hingga mengganggu suplai darah ke pulpa.⁸

Diagnosis Lesi Endodontik-Periodontik

Infeksi akut pulpa dan periodonsium harus dibedakan satu sama lain agar klinisi bisa menegakkan diagnosis yang tepat dan memulai perawatan yang sesuai. Pemahaman menyeluruh mengenai proses penyakit dan interpretasi temuan klinis serta radiografis yang benar akan membantu dokter gigi menegakkan diagnosis. Lesi periodontal dan pulpa sulit dibedakan secara akurat. Bila lesi berawal dari infeksi pulpa dan dirawat secara ekstensif dengan perawatan periodontal, lesi ini tidak akan sembuh. Sebaliknya, melakukan perawatan endodontik pada gigi vital yang mengalami kerusakan periodontal hanya akan menyebabkan persistensi infeksi.^{4,5,9}

Pasien yang menderita fase akut dari infeksi pulpa akan mengalami gejala yang biasanya tidak ada pada infeksi periodontal kronis. Selama tahap inisial pulpitis, pasien mungkin mengeluhkan nyeri dan sensitivitas yang diperparah oleh adanya stimuli tertentu, seperti perubahan suhu, tekanan, dan/atau saat menggigit.⁹

Bila gejala berasal dari pulpitis reversibel, gejala akan hilang dengan sendirinya karena adanya berbagai mekanisme seperti penutupan tubulus dentin, hilangnya toksin dan iritan mikrobial, dan pembentukan dentin reparatif. Inflamasi persisten mengarah ke pulpitis ireversibel simptomatik, yang biasanya dihubungkan dengan nyeri tajam dan spontan. Penegakan diagnosis infeksi pulpa primer harus didasarkan pada berbagai temuan objektif, seperti respon pasien terhadap perkusi,

palpasi, *probing* periodontal, dan tes vitalitas ditambah dengan evaluasi menyeluruh seluruh gejala subjektif pasien.^{3,4,8}

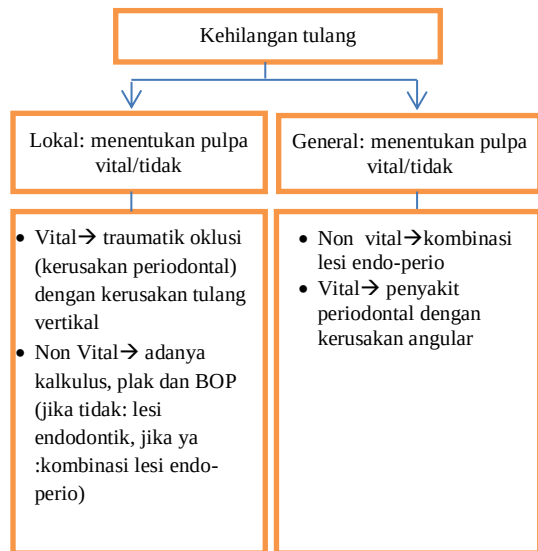
Supurasi dan drainase abses periradikuler dan periodontal juga tampak berbeda. Abses periodontal dihubungkan dengan kerusakan jaringan periodontal yang parah.^{9,11}

Infeksi periodontal tanpa keterlibatan pulpa biasanya memiliki struktur mahkota yang utuh dan tanpa kerusakan. Sebaliknya, infeksi endodontik hampir selalu dihubungkan dengan kehilangan integritas mahkota seperti karies, restorasi luas, dan adanya fraktur hingga ke pulpa. Hal ini tidak berarti bahwa infeksi periodontal tidak pernah mengalami hal yang sama. Contohnya saat jaringan pulpa cedera karena trauma, klinisi biasanya akan menemukan pulpa nekrotik walaupun tidak ada kerusakan mahkota. Bila hal ini dibiarkan, lesi yang berawal dari infeksi pulpa ini akan menyebabkan kerusakan periodonsium, seperti pada periodontitis apikal asimtomatik atau abses apikal.^{4,7,9}

Gambaran radiografis meliputi keadaan mahkota, tinggi dan bentuk tulang krestal, radiolusensi apikal atau lateral, trabekulasi tulang, integritas lamina dura, dan evaluasi hasil obturasi saluran akar bila ada. Status mahkota seperti yang ditunjukkan oleh radiograf dapat membantu memberikan diagnosis diferensial.^{5,9}

Lesi apikal yang berasal dari infeksi pulpa akan mengarah ke periodontitis *retrograde* yang berinvansi dari apeks ke servikal. Infeksi periodontal akan menyebabkan hilangnya tulang krestal dari servikal ke apikal. Lesi radiograf pada gigi yang telah dirawat endodontik akan tampak berbeda dengan gigi yang memiliki lesi periodontal.^{5,13}

Radiolusen apikal menunjukkan penyakit pulpa primer. Kehilangan tulang terbatas pada area korona bagian sepertiga gigi dihubungkan dengan penyakit periodontal primer. Guttaperca dapat digunakan sebagai alat bantu jika adanya gambaran klinis *sinus tract*, hal ini membantu dalam menentukan asal lesi saat dilakukannya pemeriksaan radiografis.^{9,10,14}



Gambar 2. Skema perbedaan Lesi Endo-Perio dari Gambaran Radiografis^{5,17}

Vitalitas

Uji vitalitas gigi seringkali menjadi uji paling penting karena dapat membedakan infeksi periodontal dengan endodontik. Gigi dengan infeksi periodontal biasanya vital saat uji termal, kecuali kondisi akut ini merupakan lesi kombinasi dimana kedua jaringan, pulpa dan periodontal telah terinfeksi. Uji termal merupakan cara yang paling dapat diandalkan untuk menentukan sehat atau tidaknya pulpa.^{4,8} Pasien dengan pulpitis ireversibel simptomatik sering mengeluhkan nyeri yang bertahan bila diberi stimulus termal. Pada tahap berikutnya, panas akan memperparah gejala, lebih daripada dingin, dan aplikasi dingin dapat menghilangkan nyeri sesaat.^{9,10,12}

Tanda klinis dan gejala nyeri akan membantu untuk membedakan antara lesi endodontik dan periodontal yaitu:^{5,12}

1. Nyeri pulpa biasanya tajam sedangkan lesi periodontal yang menyebabkan abses periodontal bisa menghasilkan rasa nyeri yang tumpul dan terasa lebih nyeri saat area abses terisi pus penuh.
2. Lesi pulpa mungkin sulit dilokalisasi saat gejala dimulai. Lesi periodontal biasanya mudah dilokalisasi.
3. Lesi pulpa biasanya memiliki *sinus tract* melalui pembentukan fistula hingga ke mukosa alveolar atau gingiva, sedangkan abses periodontal *sinus tract* melalui poket.

Probing Kedalaman Poket

Adanya poket yang dalam saat tidak adanya penyakit periodontal dapat mengindikasikan adanya lesi endodontik atau fraktur akar vertikal.^{5,7} Pemeriksaan kedalaman poket membantu dalam membedakan antara lesi endodontik dan periodontal. Ini juga bisa digunakan untuk melihat asal sinus yang dihasilkan dari lesi periapikal yang meluas ke servikal hingga ke ligamen periodontal. Pada lesi periodontal terjadi defek pada tulang alveolar dan terdapat kalkulus subgingival.^{4,11,12}

Kegoyangan gigi

Bila adanya kegoyangan di sekitar satu gigi terlokalisir, sumbernya bisa dari endodontik, periodontal, atau oklusal. Pada tahapan akut lesi endodontik, kegoyangan melibatkan gigi tunggal. Kegoyangan secara *generalisata*, melibatkan banyak gigi menunjukkan berasal dari periodontal atau oklusal.^{5,12}

Perkusi dan Palpasi

Hasil perkusi dan tes palpasi biasanya negatif pada pasien dengan masalah periodontal. Saat abses periodontal ada, secara klinis ini mungkin positif meskipun tes lainnya mengindikasikan pulpa dalam keadaan vital. Gigi dengan masalah endodontik biasanya pasti menghasilkan nyeri tekan dan nyeri pada perkusi serta palpasi.^{5,9,10}

Klasifikasi Lesi Endodontik-Periodontik

Klinisi harus mengevaluasi gejala pasien; temuan klinis dan radiografis, ada tidaknya serta lokasi pembengkakan (drainase). Berbagai variabel ini dapat dipahami mengapa kesalahan seringkali terjadi saat menentukan suatu lesi itu endodontik, periodontal atau lesi kombinasi.¹⁶⁻¹⁸

Secara umum lesi endodontik dan periodontal dapat diklasifikasikan menjadi :⁹

1. Lesi Endodontik Primer

Dikarakteristikkan dengan pulpa nekrotik serta keterlibatan area apikal secara kronis. Kemungkinan tidak terjadi keterlibatan periodontal, gambaran radiograf tidak adanya kehilangan tulang krestal.¹³



Gambar 3. Karies Pada Mahkota Gigi 36 Sampai Radiolusensi Area Furkasi dan Apikal Dan Post Perawatan Endodontik Pada Gigi 36¹¹

2. Lesi Periodontal Primer

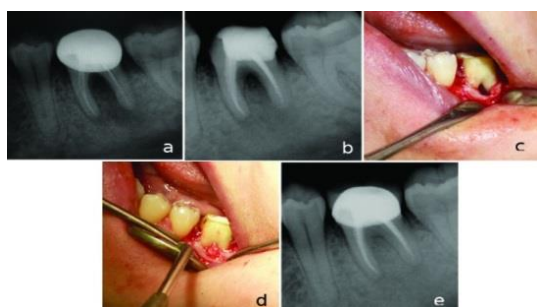
Poket periodontal yang meluas hingga ke apeks gigi. Perluasan infeksi dari poket ke pulpa terjadi pada kasus ini, tetapi kondisi pulpa tidak nekrosis. Tanpa atau adanya nyeri yang minimal dari si pasien.³



Gambar 4. Peningkatan Kedalaman Poket Periodontal pada Pemeriksaan Klinis dan Radiograf.³

3. Lesi Endodontik Primer dengan Keterlibatan Periodontal Sekunder

Jika lesi endo primer tidak didiagnosis dan dirawat lebih awal, masalah periodontal dapat terjadi dikarenakan akumulasi plak dan kalkulus pada saluran *drainase* sehingga menjadi lesi sekunder pada area jaringan periodontal. Radiograf dengan gambaran kehilangan tulang dapat terjadi pada lesi ini.



Gambar 5. a. Kunjungan pertama adanya lesi endo primer dengan keterlibatan furkasi (jar.Periodontal) pada pemeriksaan radiograf. b-c. Kontrol 3 bulan perawatan endo dengan lesi furkasi dari pemeriksaan radiograf dan klinis. d. Perawatan periodontal menggunakan aplikasi *bone graft*. e. kontrol 2 tahun post perawatan periodontal terjadi penyembuhan¹¹

4. Lesi Periodontal Primer dengan Keterlibatan Endodontik Sekunder

Lesi ini sering disebut retro-infeksi pulpa, ketika lesi periodontal meluas ke area apeks atau mengikuti kanal lateral. Lesi periodontal mungkin melibatkan pulpa nekrosis dan pasien merasakan nyeri hebat. Pulpa nekrosis bisa sebagai hasil dari terapi periodontal yang mana pembuluh darah ke pulpa terputus selama penggunaan instrumen periodontal.



Gambar 6. Gambaran radiograf awal gigi 37, setelah obturasi dan saat kontrol 1tahun yang menunjukkan penyembuhan pada area lesi¹¹

5. Lesi Kombinasi

Lesi terbentuk ketika pulpa dan periodontitis bergabung atau bebas. Lesi ini biasanya dari periodontal, gigi dengan fraktur akar vertikal juga termasuk dalam katagori lesi ini.^{5,9}. Lesi ini dapat terjadi ketika lesi endodontik meluas dari arah korona bergabung dengan lesi periodontal yang sudah ada berkembang di area apikal.

Pertimbangan Rencana Perawatan Lesi Endo-Perio

Diagnosis akurat merupakan determinan yang sangat penting dalam penatalaksanaan lesi endo-perio karena akan menentukan hasil perawatan. Faktor pertimbangan utama adalah vitalitas pulpa dan tipe perluasan dari kerusakan jaringan periodontal.^{5,9,14,18}

Penggunaan antibiotik sistemik diindikasikan bila pasien mengalami peningkatan temperatur, selulitis, penyakit sistemik dan *immunocompromised*.² Prosedur manajemen abses apikal akut, abses harus diinsisi dan drainase.^{5,12,19}

Pembersihan jaringan pulpa yang terinfeksi mikroorganisme di dalam saluran akar dilanjutkan dengan aplikasi kalsium hidroksida pada setiap salurannya. Kalsium

hidroksida terbukti sebagai medikamen intrakanal yang tepat karena stabilitas dan efek bakterisid.^{9,15} Sedangkan pada kasus dengan kehilangan struktur jaringan periodontal yang luas dapat dilakukannya terapi lanjutan yaitu terapi bedah periodontal regenerasi jika diperlukan seperti penggunaan *guide tissue regeneration* (GTR) dengan kombinasi menggunakan *bone graft*.^{4,11,19,20}

KESIMPULAN

Berdasarkan klasifikasi lesi endo-perio, dapat disimpulkan bahwa sangat penting dokter gigi mengetahui bagaimana membedakan antara etiologi lesi endo-perio, termasuk semua jalur yang menghubungkan antara pulpa dan jaringan periodonsium yang bertindak sebagai "jembatan" untuk mikroorganisme, sehingga memungkinkan penyebaran infeksi dari satu area ke area lainnya. Lesi endo-perio memiliki patogenesis kompleks dan kebutuhan keterampilan yang baik dalam mengidentifikasi serta melakukan perawatan melalui pemeriksaan klinis dan radiografis. Karenanya, kerjasama antara berbagai disiplin ilmu yang mencakup periodontis dan endodontis sangat direkomendasikan untuk perawatan lesi secara kompherensif. Perawatan lengkap dari kedua aspek lesi perio-endo sangat penting untuk keberhasilan hasil jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Maheaswari R, Selvam A, Rekha MJ, Mahalakshmi A, Jaishreetk. A Guide To Management Of Various Endodontic Periodontal Lesions- A Case Series. *Int J Cur Res Rev*. 2015; 7(20): 22–9.
- Khan RN, Kumar A, Chadgal S, Jan SM. Endo-Perio Interrelationship-An Overview. *Int J Inf Res Rev*. 2017; 4(3): 3895–8
- George PM, Ramamurthy J. Endo Perio Lesion- A Case Report. *J Med Biomed Appl Sci*. 2017; 5(2): 108–10.
- Srivastava1S, Karandikar S, Pillaiak, Karandikars, Moghe S, Singh S. Pulp Or Periodontium? Diagnosis and Management of Endo-Perio Lesion. *IOSR J Dent Med Sci*. 2014; 13(10): 90–3.
- Parolia A, Porto ICM, Gait T, Mala K. Endo-Perio Lesion: A Dilemma From 19th Until 21st Century. *J Interdiscip Dent*. 2013; 3(1): 2-9.
- Shah K, Vimala N, Naykodi T, Dharmadikari S, Padhye L. Endo - Perio Restorative Continuum - A Case Report. *Int J Oral Heath Dent*. 2016; 46(46): 265–7.
- Al-Fouzan KS. A New Classification Of Endodontic-Periodontal Lesions. *Int J Dent*. 2014; 1-5.
- Louisa M, Yuniarti S. Lesi Endoperio. *Makkasar Dent J*. 2015; 4(3): 83–91.
- Saha PH, Chakraborty A, Saha S. Endodontic-Periodontal Lesion: A Two Way Traffics. *Int J App Dent Sci*. 2018; 4(4): 223-228.
- Anand V, Govila V, Gulati M. Endo-Perio Lesion: Part I (The Pathogenesis) – A Review. *Arch Of Dent Sci*. 2012; 3(1): 3-7.
- Aksel H, Serper A. A Case Series Associated With Different Kinds Of Endo-Perio Lesions. *J Clin Exp Dent*. 2014; 6(1): 1–5.
- Sistla KP, Raghava KV, Narayan SJ, Yadalam U, Bose A, et al. Review Article Endo-Perio Continuum: A Review From Cause To Cure. *J Adv Clinical Research Insight*. 2018; 5: 188-191.
- A S, Khawar S, N S, SM A, Bhat D. Endo-perio lesion: A case report. *Int J Appl Dent Sci*. 2017; 3(3): 113–6.
- Medika CA, Sitam S, Epsilawati L. Analisis Lesi Endo-Perio di Periapikal Melalui Radiografi. *J Rad Dentomaksilofasial Ind*. 2019; 3(2): 27-30.
- Somanath G, George G, Sinha JN, Gautam V. Interdisciplinary Approach in Treatment of Endodontic- Periodontal Lesion : A Case Report. *J Univers Coll Med Sci*. 2013; 1(3): 3–6.
- Nanavati B, Bhavsar N V, Mali J. Endo periodontal lesion – A case report. *J Adv Oral Res*. 2013; 4(1): 23–6.
- Sirgamalla1 V, Sagar V, Rajababu P, Reddy V. Endo-Perio Lesion: A Case Report. *Int. J. Clin. Biomed. Res*. 2018; 4(2): 89-92.
- Alfawaz Y. Management of an Endodontic-periodontal Lesion caused by Iatrogenic Restoration: Case Report. *World J Dent*. 2017; 8(3): 1–8.
- Arora A, Goyal V, Sharma V, Gupta M, Mehta V. Fundamental In Treatment Of Endo-Perio Lesion-A Riview. *Int J Dent Clin*. 2012; 4(1): 45–6.
- Agarwal R, Singh V, Kambalyal P, Jain K. Case Report Management of Endo-Perio Lesion with Regenerative Procedure- A Case Report. *Int J Oral Health Med Res*. 2016; 3(1): 119–21.